Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Tapejara

Rua Coronel Gervásio, esquina com Avenida Sete de Setembro, 1525 - Bairro: Centro - CEP: 99950000 - Fone: (54)3046-9898 - Email: frtapejaravjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001331-21.2021.8.21.0135/RS

AUTOR: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

1. RELATÓRIO.

ANA CAROLINA DE O., neste ato representada por sua mãe, Sr.ª SIMONE GRESKI**,** ajuizou a presente ação com pedido de tutela antecipada contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, partes já qualificadas nos autos.

Relatou ser portadora de cardiopatia congênita (CID 10 — Q21.1 — comunicação interatrial), destacando que realizou procedimento de correção cirúrgica no ano de 2019. Ressaltou ainda que apresenta hipertensão pulmonar grave secundária (CID 10 — I21.2) e necessita de oxigenioterapia complementar contínua.

Alegou encontrar-se incapaz de realizar as tarefas básicas diárias, além de aguardar na fila do SUS pelo transplante cardíaco e pulmonar. Ressaltou a gravidade de sua condição, especialmente pela necessidade de fazer uso contínuo de aparelho respirador. Informou que seu núcleo familiar não possui recursos financeiros para custear as despesas decorrentes do tratamento necessário, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

Discorreu sobre os fundamentos legais da demanda. Em sede de tutela de urgência, requereu o fornecimento do equipamento concentrador de oxigênio portátil e, posteriormente, a procedência da demanda. Pleiteou a concessão da gratuidade judiciária. Juntou documentos (evento 1, DOC1).

Intimada para juntada de comprovantes da hipossuficiência alegada (evento 4, DOC1), o que foi cumprido ao evento 7, DOC1.

Recebida a inicial e concedida a gratuidade judiciária. A liminar foi indeferida e ordenada a citação do réu (evento 9, DOC1).

Citado, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contestou a demanda. Sustentou que o equipamento requerido não está padronizado, referindo que a responsabilidade deve ser suportada pela União. Sustentou que o equipamento não é dispensado pelo Estado, argumentando que a autora já realizada tratamento com respirador, embora não portátil. Ao final, requereu a inclusão da União no polo passivo com o deslocamento da competência. Subsidiariamente, pleiteou a improcedência da demanda (evento 15, DOC1).

Houve réplica.

Em parecer (evento 22, DOC1), o Ministério Público requereu o acolhimento da ilegitimidade passiva, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Determinada a regularização do polo passivo com a inclusão da União e ordenada a remessa dos autos à Justiça Federal, com baixa (evento 27, DOC1).

Suscitado conflito negativo de competência perante ao STJ (evento 38, DOC1).

Em decisão, o STJ designou este Juízo para resolver as medidas urgentes do processo (evento 42, DOC1).

Com a remessa dos autos, sobreveio despacho deste Juízo determinado a intimação das partes sobre o interesse na produção de provas (evento 50, DOC1).

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL solicitou a elaboração de nota técnica pelo sistema *e-NATJus* (evento 55, DOC1).

A União, em manifestação, pugnou pela manutenção do processo no Juízo Estadual. Requereu, ainda, a revogação de quaisquer decisões proferidas em face desta (evento 57, DOC1). Juntou documentos.

A autora manifestou o desinteresse na produção de outras provas (evento 58, DOC1).

Solicitada a nota técnica ao e-NATJus (evento 61, DOC1), que aportou ao evento 69, DOC1.

Declara a competência deste Juízo (evento 82, DOC1).

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ratificou os temos da contestação, pugnando pela improcedência da demanda (evento 89, DOC1).

O Ministério Público apresentou parecer final, no qual opinou pela procedência do pedido formulado (evento 91, DOC1).

A autora requereu o prosseguimento do feito (evento 92, DOC1).

É o relatório. Passo a decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

2.1 Da competência.

Primeiramente, ressalto que a matéria concernente à competência foi superada pela decisão de tutela incidental proferida no Recurso Extraordinário (RE) 1.366.243/SC, no âmbito da Repercussão Geral — Tema 1234. Consta, a seguir, o teor da mencionada decisão, emitida em 17 de abril de 2023 e ratificada pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) em 18 de abril de 2023:

> *"(...)*
>
> *(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;*
>
> ***(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;***
>
> *(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);*
>
> *(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário*
>
> *(...)"*

Desse modo, as ações relativas a tratamentos ou medicamentos não incorporados ao SUS devem ser processados e julgados pelo Juízo — estadual ou federal ao qual foram direcionadas pela parte, observando a determinação constante no IAC n.º 14 do STJ.

Quanto aos argumentos do Estado réu em contestação (evento 15, CONT1) e da União em manifestação (evento 57, DOC1), os quais imputam uns aos outros a responsabilidade pelo fornecimento, rejeito-os. Isso ocorre porque os equipamentos não são fornecidos pelo SUS, sendo a responsabilidade compartilhada entre os entes públicos réus e a União.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em consonância com esse entendimento, reafirmou que não é vedado ao cidadão exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes públicos, uma vez que são solidariamente responsáveis. Neste sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS.* ***Em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão. Jurisprudência pacificada. Proteção da vida e da saúde do cidadão, assegurados nos artigos 5º, caput, 6º, 196 e 203 da Constituição Federal.*** *Parte autora, adolescente, portadora de Sialorreia e Síndrome Cérebro-óculo-fácio-esquelética (COFS), a quem indicado tratamento fonoaudiológico, cabendo ao ente público ofertar atendimento na rede pública de saúde. Realização do tratamento na forma particular que somente haverá de se dar quando não oportunizado o atendimento, inclusive no que pertine à frequência prescrita, na rede pública ou entidade conveniada, suportando o ente público demandado, nessa hipótese, os custos correspondentes. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50571360220238210001, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 11-12-2023) [Grifo nosso].*

Ademais, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul consolidou a compreensão de que qualquer solicitação de ressarcimento apresentada pelo ente público responsável deve ser encaminhada à esfera administrativa ou por meio de ação específica:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NÃO PADRONIZADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENTE ESTADUAL E MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Remessa necessária. Não conhecimento. De acordo com o dispositivo do §1º do art. 496 do CPC, apenas cabe remessa necessária quando não for interposta a apelação no prazo legal. Nesse sentido, a interposição de recurso voluntário implica o não cabimento do instituto, conforme hipótese do presente caso. Precedentes do TJRS. Demais, não tem aplicação o art. 19 da Lei n. 4.717/65 no caso, porquanto a sentença foi de procedência, e não de carência ou de improcedência. 2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. O entendimento dantes adotado por este Órgão Fracionário frente ao julgamento do Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal mantinha a interpretação da necessidade da observância da responsabilidade administrativa pelo fornecimento da medicação ou tratamento, isto é, verificação de quem é o ente público responsável por custeá-lo, para que compusesse o polo passivo da relação processual onde buscado o remédio ou tratamento. Inclusive, exigia-se a presença obrigatória da União nas ações em que fosse requerido tratamento/medicamento que não fizesse parte das listas do SUS.* ***3. No entanto, diante dos diversos processos em que houve modificação da competência da Justiça Estadual para Justiça Federal, acarretando conflitos negativos de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, restou admitido o Incidente de Assunção de Competência n. 14 pela Corte da Cidadania. Ao fim, em 18/04/2023, firmada tese que, em suma, não permite, em qualquer hipótese, a inclusão da União no polo passivo pelo Juízo Estadual. Porém, no dia imediatamente posterior, 19/04/2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal referendou, por unanimidade, a decisão liminar deferida em 17/04/2023 no RE 1366243 - Tema n. 1234, pelo relator, Ministro Gilmar Mendes, restando decidido, em síntese, que (5.1) nas ações judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados haverá hipótese***

de litisconsórcio passivo necessário do ente responsável financeiro, ainda que modifique a competência jurisdicional (observação acerca da imperativa análise de eventual tutela de urgência) e (5.2) já naquelas demandas relativas a medicamentos não incorporados, manter-se-á o feito na Justiça Estadual ou Federal eleita pelo cidadão, até o julgamento definitivo do Tema n. 1234. Ainda, (5.3) vedada a desconstituição de sentenças proferidas até 17/04/2023, por inobservância dos itens anteriores. Sob esse prisma, cogente a adoção, pelo Poder Judiciário, das diretrizes estabelecidas pelo Tribunal Guardião da Constituição que, não se há olvidar, possui hierarquia jurisdicional sobre a Corte da Cidadania em matéria constitucional, como a presente. 4. In casu, os medicamentos pleiteados, Letrozol e Abemacicilibe, não constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2022 (RENAME), cuja atualização é de responsabilidade da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), conforme estabelecido pelo o Decreto n. 7.646/2011. ***Assim, trata-se de, a princípio, tratamento não padronizado e sem a devida demonstração de que, portanto, seja a União a responsável pelo seu financiamento, devendo o feito permanecer processado e julgado pelo Juízo Estadual. Nesse sentido, tanto o ente estadual quanto o municipal são solidariamente responsáveis pelo seu fornecimento e possuem legitimidade passiva no presente feito. 5. Ainda, calha ressaltar que sendo solidária a responsabilidade dos entes públicos, cabível àquele que se sentir prejudicado, entendendo que a prestação de saúde compete a outro ente, manejar o respectivo pleito de ressarcimento na via própria, mas não se esquivar do cumprimento de dever constitucionalmente estabelecido (artigo 196 da CF) perante o cidadão. Portanto, ainda que seja solidária a responsabilidade dos entes públicos e cabível àquele que se sentir prejudicado, entendendo que a prestação de saúde compete a outro ente, manejar o respectivo pleito de ressarcimento, há de ser adotada a via processual própria, para que não se desvirtue o instituto, voltado preponderantemente à mais eficaz ou célere satisfação do débito.*** Manutenção da sentença. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME. (Apelação / Remessa Necessária, N.º 50003339220228210046, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 29-11-2023) [Grifo nosso].

Assim, REJEITO a preliminar, considerando que a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça Estadual.

Desse modo, verifico a presença dos pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, igualmente as condições da ação.

Não há preliminares a serem enfrentadas. Assim, passo à análise **do mérito.**

2.2 Do mérito.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL por meio da qual a parte autora postula a obtenção do equipamento Concentrador de Oxigênio Portátil às expensas do ente estadual.

Ressalto que a questão referente ao direito à saúde está estabelecida como uma garantia fundamental, uma vez que decorre do direito à vida e é também caracterizada como um direito social, conforme disposto no caput do art. 5º e no art. 6º da Constituição Federal.

No presente caso, é importante considerar que a autora é menor de idade. Nesse contexto, além da proteção constitucional à vida e à integridade física, há uma proteção específica prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

> *Art. 4º **É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.***
>
> *Art. 7º **A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.***
>
> *Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. [Grifo nosso].*

Além disso, é necessário considerar os princípios fundamentais relacionados à saúde, especialmente em situações de urgência, como a que está sendo examinada. Isso é particularmente relevante ao lidar com uma criança ou adolescente, que detém prioridade absoluta no atendimento, conforme estipulado pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo parágrafo único, alínea "b", do art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

> *Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.*
>
> *Art. 4º. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:*
>
> *(...)*
>
> *b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;*

Da mesma forma, o art. 196 da Constituição Federal, que versa sobre a ordem social, estabeleceu o direito à saúde como uma responsabilidade do Estado. Adicionalmente, a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, em seu art. 241, estipula que a saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado, devendo ser proporcionada por meio de sua promoção, proteção e recuperação.

> *Art. 196. **A saúde é direito de todos e dever do Estado**, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*
>
> *Art. 241. A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação.*
>
> *Parágrafo único. O dever do Estado, garantido por adequada política social e econômica, não exclui o do indivíduo, da família e de instituições e empresas que produzam riscos ou danos à saúde do indivíduo ou da coletividade.*

A Lei 8.080/90, em seu art. 2º, ratificou que a saúde é um direito fundamental do cidadão, incumbindo ao Estado prover as condições para o seu pleno exercício, regulamentando o Sistema Único de Saúde (SUS) e atribuindo aos entes públicos a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde à população.

Portanto, cabe ao Estado, sem distinção entre todos os seus entes federados — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — a obrigação de assegurar aos cidadãos o direito à saúde e à vida, conforme estabelecido no art. 23, inc. II, da Constituição Federal (RE n.º 557.548/MG, Rel. Min. Celso de Mello). Destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao fixar a tese no Tema 793/STF, reiterou de forma inequívoca a presença da solidariedade entre os Entes Públicos na prestação de assistência à saúde pública à população.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada:

> *"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"*
>
> *(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL — MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)*

Vale dizer que incide no caso nos autos a determinação do item II[1] da decisão contida no Tema n.º 1234 do STF, uma vez que o equipamento postulado **não é padronizado**. Dito isso, necessária a observação do Tema Repetitivo n.º 106, o STJ, que fixou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

> ***(i)*** *Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
>
> ***(ii)*** *incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
>
> ***(iii)*** *existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.*

No caso, conforme atestado médicos (evento 1, DOC23, evento 26, DOC2), a parte autora é portadora de cardiopatia congênita (CID 10 — Q21.1) e apresenta hipertensão pulmonar grave secundária (CID 10 — I21.2) e, para o controle das doenças, necessita de concentrador de oxigênio portátil (evento 1, DOC25).

A Nota Técnica n.º 118285 emitida pelo *e-NATJus* apresentou parecer favorável à concessão do equipamento pleiteado pela demandante, nos seguintes termos:

Conclusão

Tecnologia: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de Cardiopatia congênita (CIA) operada, Hipertensão pulmonar secundária com hipoxemia e necessidade de oxigênio suplementar conforme relatório médico.
CONSIDERANDO a documentação que evidencia hipoxemia persistente e dependência de oxgenioterpia;
CONSIDERANDO os benefícios na qualidade de vida;
CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS suficientes para considerar a demanda do paciente do caso concreto verossímil e coerente com as melhores práticas para tratamento da condição de hipertensão pulmonar com hipoxemia severa. Não há urgência segundo Resolução CFM 1451/95 visto que a paciente possui concentrador de oxigênio domiciliar.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Para a análise do caso específico, destaco, em primeiro lugar, que os profissionais responsáveis pelo acompanhamento da autora possuem um conhecimento aprofundado sobre os termos da enfermidade, examinando a situação de maneira personalizada e minuciosa. Portanto, são considerados os mais aptos para indicar o tratamento adequado para o controle da doença. Da mesma forma, a nota técnica ressalta a efetividade do tratamento.

Diante das considerações médicas apresentadas, concluo que a não concessão da medicação solicitada atentaria diretamente contra o direito à saúde garantido constitucionalmente. Isso ocorre porque, devido a obstáculos de natureza administrativa, a parte autora teria significativamente prejudicada a possibilidade de redução dos efeitos decorrentes de sua enfermidade.

A necessidade da parte autora em receber o tratamento pleiteado torna-se evidente, sendo crucial para a manutenção de sua saúde. Portanto, é assegurado o direito da parte autora de ter sua saúde preservada, considerando-se a comprovada necessidade de receber os medicamentos, o que garantirá uma melhor qualidade de vida à adolescente.

O concentrador de oxigênio portátil mostra-se necessário em razão da autora usar oxigênio por 24h, e o concentrador fornecido pelo SUS ser de uso domiciliar, impedindo seu transporte quando o adolescente necessita sair de casa para consultas, exames e outras eventuais saídas de sua residência.

Nesse contexto, evidencia-se que o tratamento mencionado é essencial para a preservação de sua saúde, fundamentando a validação da antecipação de tutela concedida. Portanto, o **primeiro requisito** encontra-se devidamente atendido.

Quanto à condição financeira da parte, **consistente no segundo requisito**, tanto a parte autora, menor de idade, quanto seus genitores evidenciaram a falta de recursos para arcar com os custos do tratamento sem prejudicar o sustento familiar (evento 7, DOC3, evento 7, DOC4, evento 7, DOC7 evento 7, DOC10, evento 7, DOC11, evento 7, DOC12, evento 7, DOC13, evento 7, DOC14). Além disso, os orçamentos apresentados comprovam o elevado custo do equipamento (evento 7, DOC16, evento 7, DOC17), justificando a necessidade do fornecimento pelo Ente Público.

Em relação ao **terceiro requisito**, verifica-se que o fármaco se encontram devidamente registrados e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (evento 69, NOTATEC1). A Secretaria Estadual de Saúde indeferiu o pedido administrativo de fornecimento dos medicamentos sob o argumento de que estes não eram disponibilizados pelo SUS (evento 1, CERTNEG29).

Logo, demonstradas a necessidade da providência médica e a carência financeira, bem como o incontroverso registro dos medicamentos junto à ANVISA, à luz do Tema 106 do STJ, forçoso reconhecer a responsabilidade do réu pelo fornecimento do equipamento postulado.

Por tais razões, a procedência do pedido é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por ANA CAROLINA DE OLIVEIRA, representada por sua genitora, Sr.ª SIMONE GRESKI contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, para o fim de **CONDENAR** o réu a **fornecer o equipamento concentrador de oxigênio portátil**, conforme laudos médicos juntados ao feito, ou disponibilizar o equivalente em dinheiro, observado o menor orçamento, sob pena de bloqueio de valores, em caso de impossibilidade do cumprimento da obrigação.

Condeno os demandados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, atualizado pelo IPCA-E desde o ajuizamento, em consonância com o disposto no art. 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas, por aplicação do § 2º do artigo 141, da Lei n.º 8.069/1990.

Em sendo opostos embargos de declaração, dê-se vista deles à parte embargada, para que, querendo, exerça o contraditório, em 05 dias (artigo 1.023, § 2°, do CPC). Após, voltem para julgamento.

Em face da sistemática do Código de Processo Civil, notadamente no que diz respeito à inexistência de admissibilidade no juízo *a quo* (art. 1.010, § 3º, do CPC), desnecessária a remessa do feito à conclusão.

Logo, em caso de interposição de recurso por qualquer dos litigantes, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular n.º 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados, vinculando o número do processo de conhecimento e recolhendo as custas correspondentes, se for o caso.

OBSERVAÇÃO. Em caso de remessa dos autos à Instância Recursal, havendo necessidade do cumprimento da decisão, deverá a parte autora ajuizar procedimento de cumprimento provisório de sentença por dependência ao presente feito, diante da impossibilidade de acesso aos autos pelo Juízo no período da tramitação do recurso.

Sentença não sujeita a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 4º, do CPC, uma vez que a responsabilidade dos entes públicos pelo direito discutido é matéria pacificada no STJ e no STF (ex.: RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em Repercussão Geral em 05/03/2015).

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria de Saúde do Estado, comunicando a decisão proferida.

Sentença registrada e publicada eletronicamente.

Agendada a intimação das partes intimadas via sistema Eproc.

Documento assinado eletronicamente por **NÚBIA DE MIRANDA FRIÁS, Juíza de Direito**, em 28/1/2024, às 21:55:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10052920945v52** e o código CRC **026f7bae**.

---

1. "[...](ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;[...]" ↩